MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE L'INSUFFISANCE RENALE

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2026

PLANTable des matières

Contexte et justification

Chapitre 1 : Brève présentation de la structure

Chapitre 2 : l’évaluation du PTAB 2025

Chapitre 3 : Priorités de l’année 2026

Chapitre 4 : Cadre logique

Chapitre 5 : Récapitulatif budgétisé

Introduction Contexte et justification

Le Programme National de Lutte contre l'Insuffisance Rénale (PNLIR), créé par décret n°2019-225 du 13 août 2019, a pour mission la prévention, la prise en charge et la recherche sur les maladies rénales en République du Congo. L'insuffisance rénale(IR) qu'elle soit aiguë ou chronique constitue un véritable problème de santé publique en République du Congo. En 2021, près de 52,1% des patients admis au service de néphrologie au CHU de Brazzaville avaient une Insuffisance Rénale Chronique (IRC) et 3, 87% une Insuffisance Rénale Aiguë (IRA). Le taux de létalité est estimé à 49,9% ; un taux élevé rattaché directement à l'inaccessibilité de l'hémodialyse en raison de son coût élevé. Le programme national de lutte contre l'insuffisance rénale (PNLIR) a rapporté en 2021 une incidence nationale de près de 251 nouveaux cas d'IRC au stade de dialyse/an et un taux d'accès à l'hémodialyse à 13.8 %. Il y a donc urgence de miser sur la prévention de l'IR au sein de la population générale mais surtout celle à risque.

L'évaluation du Plan de Travail Annuel Budgétisé (PTAB) 2025 a révélé un taux de réalisation de 31,57%, principalement freiné par des contraintes de financement, une faible mobilisation des parties prenantes et des insuffisances logistiques.

Le présent PTAB 2026, extrait du Plan Stratégique National (PSN) 2025-2029, se veut un instrument réaliste et orienté vers les résultats probants, avec 19 activités clés réparties en quatre programmes prioritaires, notamment : **gouvernance, offre de soins, promotion de la santé et gestion de l'information**.

Chapitre 1 : 2. PBrève présentation de la structure

Dans le cadre de la lutte intégrée contre les maladies chroniques non transmissibles parmi lesquelles l'insuffisance rénale, il a étéa été créé par décret présidentiel n°2019-225 du 13 août 2019 un programme dénommé « Programme National de Lutte contre l'Insuffisance Rénale (PNLIR) » placé sous la tutelle du auprès du Ministère de la Santé et de la Ppopulation, par décret présidentiel 2019-225 du 13 août 2019, un programme dénommé « programme national de lutte contre l'insuffisance rénale (PNLIR) ».

Le programme national de lutte contre l'insuffisance rénale est chargé, notamment, de :

- oorganiser les activités préventives contre l'insuffisance rénale ;
- informer et sensibiliser la population en général et particulièrement les groupes à risques ;
- faciliter l'accessibilité aux soins d'hémodialyse, au bilan pré et post dialytique et aux médicaments ;
- élaborer les bonnes pratiques pour une prise en charge optimale des sujets atteints d'insuffisance rénale ;
- collecter et analyser les données statistiques du programme ;

- planifier, coordonner et superviser les activités de lutte contre l'insuffisance rénale ;
- émettre des recommandations de bonnes pratiques pour une prise en charge optimale des sujets atteints d'insuffisance rénale ;
- mobiliser les ressources nécessaires à la lutte contre l'insuffisance rénale ;
- promouvoir la recherche et la formation sur l'insuffisance rénale ;
- participer à la mise en œuvre et au suivi des activités de partenariat.

Le programme national de lutte contre l'insuffisance rénale comprend :

- la direction du programme ;

- le comité scientifique d'appui.

La direction du programme est dirigée et animée par un directeur nommé par décret du Premier ministre, chef du Gouvernement, sur proposition du ministre chargé de la santé. La direction du programme, outre le secrétariat, comprend :

- lLe département de la prévention et de la prise en charge thérapeutique de l'insuffisance rénale ;
- lLe département du dépistage et de la surveillance épidémiologique de l'insuffisance rénale ;
- lLe département de la recherche et de la formation ;
- lLe département de la gestion et de la logistique ;
- lLe département de la documentation, des archives et de la statistique.

LLe Programme National de Lutte contre l’Insuffisance Rénale (PNLIR)PNLIR està son local est actuellement situé dans l’enceinteau sein du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Brazzaville (Avenue Auxence Ickonga, Poto Poto), à côté des bâtiments abritant le PNLS.

3. Objectifs

3.1 O général

3.2. O spécifiques

4. Résultats attendus

Chapitre 2 : l'évaluation du PTAB 2025

5. Analyse de la situation du PTAB 20

Activités prévues	Niveau de réalisation	Observations
Programme1. Gouvernance, leadership et pilotage du Programme National de Lutte contre l'Insuffisance Rénale		
Sous-programme1-1. Renforcement de la gouvernance, du leadership et du pilotage des activités du Programme National de Lutte contre l'Insuffisance Rénale		
OS 1. Renforcer la gouvernance, le leadership et le pilotage des activités du Programme National de Lutte contre l'Insuffisance Rénale au Congo		
A1 :Organiser l'atelier de validation du Plan Stratégique National (PSN)		Rien à signaler
A2 : Tenir des réunions d'activités par trimestre sur les interventions du PSN		Retard de financement
A3 : Organiser au moins 4 réunions d'élaboration et la validation du PTAB /an		Retard de financement

A4 : Faire un plaidoyer pour un local et un véhicule de liaison pour le PNLIR auprès du MSP		Rien à signaler
Sous-programme1-2. Mobilisation des fonds et développement du partenariat		
OS 2. Mobiliser les fonds suffisants et durables pour la lutte contre l'insuffisance rénale et le développement du partenariat		
A5 : Organiser un atelier d'élaboration d'un plan de mobilisation des ressources		
A6 : **F**aire un plaidoyer au MSP et au Ministère des finances pour l'amélioration de la procédure administrative de l'acquisition du budget alloué au programme		
Programme 2. Renforcement de l'offre de soins et des services de prise en charge de l'IR		
OS 3. Renforcer l'offre de soins et des services de prise en charge de l'insuffisance rénale		
A7 : Organiser un Atelier Direction -PNLIR et comité scientifique pour l'élaboration et la validation d'algorithmes des soins pour l'insuffisance rénale et ses principaux facteurs de risque (Hypertension artérielle et Diabète Sucré).		Absence de financement
A8 :Assurer la dotation des algorithmes de soins de dépistage et de prise en charge de la maladie rénale au		Absence de financement

niveau de 25 FOSA ainsi que les kits de dépistage et de prise en charge.		
A9 : Organiser au moins 2 réunions pour la proposition de mise en place de la gratuité des érythropoïétines		Absence de financement
A10 : Organiser des réunions de plaidoyer pour l'intégration des activités de dépistage et de prise en charge dans les districts sanitaires		Absence de financement
A11 : Organiser au moins 3 réunions avec les parties prenantes pour la mise en place d'une unité de gestion et ravitaillement des consommables d'hémodialyse au niveau du PNLIR.		Absence de financement
A12 : Organiser un atelier résidentiel de formation de 4 jours sur le dépistage et la prise en charge de la maladie rénale d'au moins 40 prestataires de soins dans les FOSA des départements		Absence de financement
OS 5. Renforcer la collaboration avec la CAMEPS pour la gestion des médicaments et consommables de la dialyse.		
A13 : Organiser une réunion de coordination pour la gestion et le ravitaillement des consommables d'hémodialyse au		Absence de financement

PNLIR		
Programme 3. Promotion de la santé rénale		
OS 6. Renforcer la prévention de l'insuffisance rénale et la promotion de la santé rénale dans la population générale et à risque		
A14 : Organiser une campagne de dépistage et de sensibilisation sur l'insuffisance rénale : Journée mondiale du Rein 2025		Absence de financement
A15 : Organiser une campagne de sensibilisation dans le milieu scolaire et Professionnel		Absence de financement
A16 : Organiser un atelier de formation présentielle de 4 jours de 30 relais communautaires pour la sensibilisation sur les facteurs de risque et la prévention de l'insuffisance rénale dans les districts sanitaires au niveau des communautés		Absence de financement
A17 : Organiser une campagne de dépistage et de sensibilisation sur l'hypertension artérielle : Journée mondiale de l'Hypertension Artérielle		Rien à signaler

A18 : Organiser une campagne nationale de dépistage et de sensibilisation sur le diabète sucré		Absence de financement
A20 : Organiser un atelier résidentiel ou présentiel pour l'élaboration et la validation du guide de surveillance épidémiologique de la maladie rénale et ses facteurs de risque		Retard de financement
Programme 4. Gestion de l'information sanitaire et de la recherche sur l'insuffisance rénale		
OS 7. Mettre en place un système de surveillance épidémiologique et de gestion de données sur l'insuffisance rénale		
A21 : Organiser un atelier résidentiel d'intégration et de paramétrage des indicateurs de l'insuffisance rénale dans le DHIS2		
A22 : Organiser un atelier ou séance de travail pour l'élaboration et la validation de support de collecte de données		
A23 : Proposer un thème de recherche sur l'insuffisance rénale aux étudiants de la FSSA/UNMG		
100%	**≥50**	**0%**

31,57% des activités prévues dans le PTAB 2025 sont réalisées et 8% en cours de réalisation.

Programme1 : Gouvernance, leadership et pilotage du programme	
Forces	Faiblesses
• Existence d'un cadre juridique et institutionnel solide (décret présidentiel n°2019-225). • Existence d'un PSN 2025–2029 • Existence d'un PTAB 2025. • Engagement du Ministère de la Santé et de la Population pour la mise en œuvre du PSN.	• Insuffisance de mobilisation des fonds pour la réalisation des interventions du programme ; • Faible coordination intersectorielle ; • Insuffisance de réunions coordinations ; • Insuffisance des PTFs ; • Ressources humaines et matérielles limitées pour l'administration du programme.

• Existence d'un projet de création d'un comité scientifique d'appui et d'une structure fonctionnelle.	• Organigramme du programme incomplet.
Opportunités	Menaces
• Existence des partenaires techniques et financier(PTFs). •	• Instabilité économique; • Procédure complexe de décaissement des fonds alloués au fonctionnement du PNLIR ; • Risque de perte d'élan institutionnel en cas de changement de priorités nationales.
programme 2 : Renforcement de l'offre de soins et de services de prise en charge de l'IR	
Forces	Faiblesses
• Existence de deux (2) centres de dialyse publics intra hospitalier (CHU-B et , HGELBO) ; • Existence de sept (7) centres de dialyse privés (Brazzaville et Pointe-Noire) ; • Existence des services de néphrologie dans les hôpitaux généraux du pays ; • Existences de onze (11) spécialistes qualifiés en néphrologie dans le pays (Brazzaville, Pointe-Noire, Oyo).	• Non d'intégration des activités de prise en charge de l'IR dans le district sanitaire (soins de santé primaire) ; • Absence d'algorithmes de soins ; • Absence d'une politique de gratuitegratuité des … médicaments essentiels ; • Insuffisance de spécialistes qualifiés en néphrologie au niveau national et inégalement répartis ; • Insuffisance de mobilisation des fonds pour les activités de prise en charge des maladies rénales.
Opportunités	Menaces
• Existence des partenaires techniques et financier(PTFs).	• Procédure complexe de décaissement des fonds alloués

• Croissance de l'intérêt des institutions pour la prise en charge des MNT.	au fonctionnement du PNLIR ; • Instabilité économique;
Programme 3 : Promotion de la santé rénale	
Forces	Faiblesses
• Organisation des'une campagnes annuelle de sensibilisation, de dépistage et de prise en charge des cas d'insuffisance rénale. • Existence des comités de santé (COSA) et des comités de gestion (COGES). • Existence d'une Direction de la Santé Scolaire et Universitaire. • Institutionnalisation des Journées Internationales du Rein ainsi que des principaux facteurs de risque de l'insuffisance rénale chronique (HTA, diabète sucré, tabac, obésité ...).	• Absence d'une stratégie nationale de communication et de mobilisation sociale. • Insuffisance des fonds mobilisés dans la promotion de la santé rénale et la prévention des maladies rénales ; • Non-intégration de la prévention rénale dans les programmes de santé communautaire
Opportunités	Menaces
• Intérêt croissant du public pour les maladies non transmissibles • Possibilité d'appui des médias et de la société civile dans la sensibilisation.	• Instabilité économique.

• Alignement avec la Politique Nationale de Promotion de la Santé	
Programme4: Gestion de l'information sanitaire et recherche sur l'insuffisance rénale	
Forces	Faiblesses
• Existence du département de documentation, des archives et de la statistique au sein du PNLIR. • Le département du dépistage et de la surveillance épidémiologique de l'insuffisance rénale ; • Élaboration en cours du Guide national de surveillance épidémiologique de l'insuffisance rénale.	• Non-intégration des indicateurs IR dans le DHIS2. • Absence de base de données nationale consolidée sur les maladies rénales. • Faible capitalisation de la recherche nationale sur l'insuffisance rénale.
Opportunités	Menaces
• Existence des partenaires techniques et financier (PTFs) • Possibilité detentiel de collaboration avec les structures universitaires et de recherche. • Intérêt des partenaires pour la production de données probantes sur les MNT.	• Instabilité économique; • Faible financement dédié à la recherche opérationnelle.

Les principaux problèmes identifiés sont :

Programme1 : Gouvernance, leadership et pilotage du programme

- Insuffisance de mobilisation des fonds pour la réalisation des interventions du programme ;
- Faible coordination intersectorielle ;
- Insuffisance de réunions coordinations ;
- Insuffisance des PTFs ;
- Instabilité économique;
- Faible coordination intersectorielle et absence d'une plateforme nationale de lutte contre les MNT incluant l'IR.
- Insuffisance de partenariats techniques et financiers formalisés.

Programme 2 : Renforcement de l'offre de soins et de services de prise en charge de l'IR

- Non d'intégration des activités de prise en charge de l'IR dans le district sanitaire (soins de santé primaire) ;
- Absence d'algorithmes de soins ;
- Absence d'une politique de gratuite des … ;
- Insuffisance de mobilisation des fonds pour les activités de prise en charge des maladies rénales.
- Insuffisance de ressources matérielles et financières allouées au PNLIR pour son fonctionnement ;

- Insuffisance des fonds alloués au PNLIR pour répondre aux nombreux défis liés à la prise en -charge de l'insuffisance rénale au Congo ;
- Absence de Partenaires Techniques et Financiers. ;
- L'insuffisance des ressources humaines qualifiées en dialyse ;
- Les problèmes de qualité des prestations de soins (pas de consensus sur des protocoles thérapeutiques, scientifiquement validés pour les maladies rénales chroniques).

Programme 3 : Promotion de la santé rénale

- Absence d'une stratégie nationale de communication et de mobilisation sociale.
- Insuffisance des fonds mobilisés dans la promotion de la santé rénale et la prévention des maladies rénales ;
- Non-intégration de la prévention rénale dans les programmes de santé communautaire
- Insuffisance dans l'IEC pour un changement de comportement à travers des actions efficaces ciblées

Programme4 : Gestion de l'information sanitaire et recherche sur l'insuffisance rénale

- Manque d'information de la population sur l'insuffisance rénale et ses facteurs de risque ;

- Insuffisance dans l'IEC pour un changement de comportement à travers des actions efficaces ciblées sur les comportements individuels, l'environnement social et économique, l'environnement physique ainsi que l'organisation.
- Insuffisance d'informations sur l'insuffisance rénale au Congo ;
- Non-intégration des indicateurs IR dans le DHIS2.
- Absence de base de données nationale consolidée sur les maladies rénales.
- Faible capitalisation de la recherche nationale sur l'insuffisance rénale.

Chapitre 3 :6. Priorités de l'année 2026

Programme1 : Gouvernance, leadership et pilotage du programme

- Renforcer les ressources humaines du PNLIR en quantité et en qualité ;
- Insuffisance Renforcer le plaidoyer sur lade mobilisation des fonds ressources (matérielles et financières) pour la réalisation des interventions du programme ;
- Faible Renforcer la coordination intersectorielle. ;
- Insuffisance de moyens logistiques de base (véhicule, local) ;
- Insuffisance des PTFs ;

Programme 2 : Renforcement de l'offre de soins et de services de prise en charge de l'IR

- Non iIntégrerration ldes activités de dépistage et de PEC de l'IR/MRC au niveau des districts sanitaires ;

- Faire Non gratuitéle plaidoyer auprès des partenaires publics et privés (PPP) pour la gratuité des médicaments essentiels liés à l'hémodialyse ;
- Faire le plaidoyer pour la mise en place d'Insuffisances desun centres de dialyse public au niveau nationaldans le département de Pointe-Noire ;
- Faire le plaidoyer pour la formation Insuffisance des personnels de santé spécialisés dans la prise en charge de l'insuffisance renale (infirmiers, biotechniciens, néphrologues) ;
- Faire le Absence plaidoyer pour la mise en place d'uned' unités de dialyse péritonéale dans les hôpitaux généraux.

Programme 3 : Promotion de la santé rénale

- Absence dElaborer ' une stratégie nationale de communication et de mobilisation sociale sur l'insuffisance rénale;
- Faire un plaidoyer pour la mobilisation Insuffisance des fonds mobilisés dans le cadre de la promotion de la santé rénale et la prévention des maladies rénales ;
- Non iIntégreration ldes activités de promotion de la santé rénale dans les districts sanitaires ;
- Insuffisance Renforcerde la Communication sur les Risques et Engagement Communautaire CCCD (CREC Communication pour le changement de comportement durable) à travers des actions efficaces ciblées.

Programme 4 : Gestion de l'information sanitaire et recherche sur l'insuffisance rénale

- INon-intégreration ldes indicateurs IR dans le DHIS2 ;.

- Absence de données nationales sur l'insuffisance renale (absence de registre national)Mettre en place un mécanisme de surveillance de la maladie rénale ;
- Faible capitalisation de la recherche nationale sur l'insuffisance rénale ;

Chapitre 4 : Activités prévues par axes stratégiques traduit en termes de programme en fonctions des priorités définies et Résultats

Programme1 : Gouvernance, leadership et pilotage du programme

- Elaboration et validation du PTAB 2026 et d'un plan de mobilisation des ressources ;
- Tenir des réunions de coordination ;
- Initier les rentres avec les differents PTFs.

Programme 2 : Renforcement de l'offre de soins et de services de prise en charge de l'IR

- Plaidoyer auprès de MSP et les parlementaires pour l'intégration des activités de dépistage et de prise en charge de la maladie rénale est faite
- Elaboration et de validation du guide de prise en charge de maladie rénale et l'algorithmes du dépistage et prise en charge de l'IR
- Plaidoyer auprès MSP pour la formation des personnels soignants des maladies rénales à l'étranger et la mise place d'une unité de dialyse péritonéale dans les services de pédiatrie

Programme 3 : Promotion de la santé rénale

- Compagne de sensibilisation de la maladie rénale sur ses facteurs de risque, dépistage et prise en charge des cas
- Compagne de sensibilisation, dépistage et prise en charge des cas (HTA, diabète sucre) sur les facteurs de risques de l'IR ;
- Elaboration d'un plan de communication des agents et les relais communautaires.

Programme 4 : Gestion de l'information sanitaire et recherche sur l'insuffisance rénale

- Elaboration et validation de la surveillance épidémiologique de la maladie rénale et des outils de collecte de données ;
- Paramétrage des indicateurs de l'IR dans $DSHI_2$;
- Réalisation deux (2) études sur la maladie rénale (IR).

Chapitre 5 :7. Cadre logique

Programme1. Gouvernance, leadership et pilotage du Programme National de Lutte contre l'Insuffisance Rénale											
Objectifs	**Résultats attendus**	**Activités**	**Indicateurs de suivi**	**Source de vérification**	**Responsables**	**Financement**		**Chronogramme**			
						Coût (FCFA)	**Source**	**T1**	**T2**	**T3**	**T4**
Objectif n°1 : Organiser des réunions de coordination pour les interventions du programme.	**Résultat attendu n°2 :** Les réunions de coordination pour l'intervention du programme sont organisées	**A1**. Organiser une réunion de coordination mensuelle	Nombre de réunions réalisés	La liste de présence de la réunion	**PNLIR**	**0**	PNLIR	X	X	X	X
		A2. Organiser une réunion trimestriel pour l'évaluation des interventions	Nombre de réunions réalisés	Comptes rendue des réunions	**PNLIR**	**0**	PNLIR	X	X	X	X

Objectif n°2 : Elaborer et valider le PTAB 2026 du PNLIR en 2026.	**Résultat attendu n°2 :** le PTAB 2026 du PNLIR est validé et disponible en 2026.	**A3**. Organiser les séances de travailles pour ld'élaboration du PTAB 2026 ; **A4**.Organiser un atelier de validation du PTAB 2026.	Le nombre d'ateliers de séances de travail organiséesd'élaboration et de validation réalisés. Nombre de plan disponiblevalidé et disponible	La liste de présence des ateliers Les rapports d'activités	**Direction PNLIR** **Direction PNLIR**	**100000** **500000**	PNLIR PNLIR	X X			
Objectif n°3 : Elaborer et valider un plan de mobilisation des ressources en 2026	**Résultat attendu** **n°3** : Un plan de mobilisation des ressources est élaboré, validé et disponible	**A5.** Organiser des séances de travailles pour l'élaboration et la validation du plan de mobilisation des ressources **A6.** Organiser un atelier de validation du plan de mobilisation des ressources	NLe nombre d'ateliers d'élaboration et de validationséances de travail réalisées. Nombre de plan validé et disponible	Comptes rendus des réunions. Les rapports d'activités.	**PNLIR**	**100000** **0**	PNLIR	X	X		

Objectif n°4 : Faire un plaidoyer auprès MSP pour l'acquisition d'un local et d'un véhicule	**Résultat attendu n°4** : Un plaidoyer auprès de MSP pour l'acquisition d'un local et d'un véhicule est fait	**A76.** Faire un plaidoyer auprès de MSP Pour l 'acquisition d'un local et d'un véhicule	Nombre de plaidoyers réalisés. Nombre de local et de véhicule obtenus	Comptes rendus des réunions.	**PNLIR**	0	PNLIR	X	X	X	X
Objectif n° 5 : Faire un plaidoyer auprès des PTFs (OMS, PNUD, FM...) pour le financement des interventions du PNLIR.	**Résultat attendu n° 5 :** Un plaidoyer auprès des PTFs (OMS, PNUD, FM...) pour le financement des interventions du PNLIR est fait.	**A.87 :** Organiser des réunions auprèsavec ldes PTFs sélectionnés pour le financement des interventions du programme en collaboration avec l'UCPP/MSPDIRCO	Nombre de réunions réaliséstenus. Nombre de contrats de partenariat obtenus Nombre d'interventions financiers par les PTFs	La liste de présence ; Existence des contrats de partenariats Compte rendus de la réunionsde la réunion.	**PNLIR**	**358500**	PNLIR	X	X	X	X

Programme 2 : Renforcement de l'offre de soins et de services de prise en charge de l'IR											
Objectif n°6 : Faire un plaidoyer auprès de MSP et pour l'intégration des activités de dépistage et de prise en charge de la maladie rénale(IR)	**Résultat attendu n°6 :** Un plaidoyer auprès de MSP et pour l'intégration des activités de dépistage et de prise en charge de la maladie rénale est faite	**A.98 :** Organiser un atelier d'élaboration et de validation d'un plan stratégique d'intégrationdes directives nationales des activités de dépistage et de prise en charge de la maladie rénale	Nombre de directives élaborées et validées de plans stratégique d'intégration des activités de dépistage et de prise en charge de la maladie rénale	Rapport d'activité	**PNLIR** **MSP DGS SSa**	**1200000**	PN LIR		**X**	**X**	**X**

		A.109 : Organiser des réunions de plaidoyer auprès de MSP pour l'intégration des activités de dépistage et de prise en charge de la maladie rénale au niveau des Districts Sanitaire.	Nombre de réunions plaidoyer réalisées	Compte rendu de l'activité.		**700000**	PN LIR		X	**X**	**X**
Objectif n°7 : Faire un plaidoyer pour la création d'un centre d'hémodialyse à Pointe Noire	**Résultat attendu n° 7** : un plaidoyer pour la création d'un centre d'hémodialyse à Pointe Noire est fait	**A.110 :** Faire un plaidoyer pour la création d'un centre d'hémodialyse à Pointe Noire	Nombre de centre d'hémodialyse créé à Pointe Noire	Compte rendu des plaidoyerdes plaidoyers	PNLIR	**0**	PN LIR		X	X	X
Objectif n°8 : Faire un plaidoyer pour la mise en place d'un projet de greffe renale au	**Résultat attendu n°8 :** plaidoyer pour la mis en place d'un projet de	**A.121 :** Faire un plaidoyer pour la mise en place	Nombre de plaidoyers réalisés ;	Compte rendu du plaidoyer	MSP PNLIR	**0**	PN LIR		X	X	X

Congo	greffe rénale réalisés	d'un projet de greffe rénale au Congo	Nombre de projet de greffe rénale mise en place au Congo								
Objectif n°9: Créer une unité de coordination des centre de dialyse ou hémodialyse au PNLIR (Congo)	**Résultat attendu n°9 :** une unité de coordination de centre de dialyse ou hémodialyse au PNLIR (Congo) est créé	**A.132 :** Organiser une réunion de plaidoyer pour la création d'une unité de coordination des centres de dialyse ou d'hémodialyse au PNLIR	Nombre de réunions organisées Nombre d'unitéNombre d'unité de coordination des centres de dialyse ou d'hémodialyse au PNLIR créé	Compte rendu du plaidoyer	MSP PNLIR	100000	PTFs MSP		**X**	**X**	**X**

Programme 3. Promotion de la santé rénale											
Objectif n°10: Organiser une campagne de sensibilisation de la population générale et des districts sanitaires sur les facteurs de risque de l'IR, le dépistage et la prise en charge des cas	**Résultat attendu n°10 :** une campagne de sensibilisation de la population générale et des districts sanitaires sur les facteurs de risque de l'IR, le dépistage et la prise en charge des cas est	**A.143 :** Organiser les séminaires de sensibilisation sur les facteurs de risque de l'IR, le dépistage et la prise en charge des cas dans les districts sanitaires deux à Brazzaville et à Pointe Noire	Nombre de séminaires de sensibilisation organisées. Nombre de districts sanitaires et CSI ayant bénéficiés du séminaire Nombre de	Rapport d'activités.	**MSP PNLIR.**	**9040000**	PT Fs PN LIR	X	X		

	organisée	**A.154 :** Organiser une sensibilisation audiovisuelle de la population générale avec les NTIC	personnels de santé (districts sanitaires et CSI) sensibilisées sur les facteurs de risques, dépistées et prise en charges de l'IR/MRC. Nombre de vidéos produites et mise en ligne par trimestre Nombre de vues sur NTIC par trimestre Nombre de vidéos par trimestre			**1500000**			X	X	X
Objectif n°11 : Organiser une campagne de sensibilisation, de dépistage et	**Résultat attendu n°11 :** une campagne de	**A.165 :** Organiser campagne de sensibilisation, de dépistage et	Nombre de campagne de sensibilisation, de dépistage et de prise en	Rapports d'activités.	**PNLIR** **MSP**	**7 619 800**	PT Fs PN			X	X

de prise en charge de cas de l'HTA	sensibilisation, de dépistage et de prise en charge de cas de l'HTA est réalisée	de prise en charge de cas de l'HTA (à l'occasion de la Journée Mondiale en mai 2026) en collaboration avec la Société Congolaise de Cardiologiel'hypertension artérielle.	charge de cas de l'HTAorganisées ; Nombre de personnes sensibilisés, dépistés et prise en charge.		**SCHAMI** **DELM** **DHPS**		LIR				
Programme 4. Gestion de l'information sanitaire et de la recherche sur l'insuffisance rénale											
Objectif n°12: Organiser un atelier d'élaboration et de validation du guide de surveillance épidémiologique de la maladie rénale (IR)	**Résultat attendu n°12 :** un atelier d'élaboration et de validation du guide de surveillance épidémiologique de la maladie rénale (IR) est organisé	**A.176 :** Organiser un atelier d'élaboration et de validation du guide de surveillance épidémiologique de la maladie rénale (IR) et des outils de collecte de données	Nombre d'atelier d'élaboration et de validation du guide de surveillance épidémiologique de la maladie rénale et des outils de collecte de données de la maladie rénale organisé(IR)	Rapport d'activité	**MSP** **PNLIR** **DISER.**	**1088000**	PT Fs PN LIR	**X**	X	X	

			Nombre de guide de surveillance épidémiologique de la maladie rénale (IR) de la maladie rénale élaboré, validé et disponibles								
Objectif n°13 paramétrer des indicateurs de surveillance épidémiologique de la maladie rénale (l'IR) dans le DHIS2 des hôpitaux	**Résultat attendu n°13** : Les indicateurs de surveillance épidémiologique de la maladie rénale (l'IR) sont paramétrés dans le DHIS2 des hôpitaux	**A.187 :** Organiser un atelier résidentiel de paramétrage des indicateurs de surveillance épidémiologique de la maladie rénale (l'IR) dans le DHIS2 des hôpitaux	Nombre d'atelier de paramétrage les indicateurs de surveillance de l'IR dans le DHIS2 sont paramétrés Nombre d' indicateurs de surveillance de l'IR paramétrés dans le DHIS2 accessibles	Rapport d'activité	**MSP** **PNLIR** **DISER**	**15000000**	PTFs PNLIR			X	X
Objectif n°14 : Réaliser une étude CAP sur	**Résultat attendu n°14 :** Une étude de sur	**A.198 :** Réaliser une d' étude CAP sur l'IR	Nombre d'études CAP sur l'IR réalisée	**MSP** **PNLIR**	PNLIR	**2500000**		**X**	X	X	X

l'IR	l'IR est réalisée										
Objectif n° 15 : Mettre en place un registre national de la maladie rénale (IR)	**Résultat attendu n°15 :** un registre national de la maladie rénale (IR) est mis en place	**A. 2019:** Organiser un atelier présentiel dl'élaboration et lade validation d'un registre national de la maladie rénale (l'IR)	Nombre de registre de la maladie rénale (l'IR) est élaboré et validé	**MSP** **PNLIR**	PNLIR PTFs	**7925000**			X	X	X

Au total , 2019 activités sont prévues pour 2026

Chapitre 6 : Récapitulatif budgétisé

Synthèse financière	Coût (FCFA)
Programme1. Gouvernance, leadership et pilotage du Programme National de Lutte contre l'Insuffisance Rénale	**1 058 500**
Programme 2. Renforcement de l'offre de soins et des services de prise en charge de l'IR	**12 800 000**
Programme 3. Promotion de la santé rénale	**31 659 800**
Programme 4. Gestion de l'information sanitaire et de la recherche sur l'insuffisance rénale	**27 313 000**
Rémunération du personnel	**20 840 000**
Matériels et fournitures de fonctionnement	**4 500 000**
Total général :	**98 171 300**

Fait à Brazzaville, le

Le Directeur de Programme